ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА · ЛЕКЦИЯ 2 · ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Приёмное отделение и медицинская документация

Пути и виды госпитализации, функции, задачи и устройство приёмного отделения, учётные формы 001/у, 003/у, 004/у, 058/у и др.

👤 Сажнова Елена Юрьевна

1. Как пациенты попадают в стационар
2. Приёмное отделение
3. Функции приёмного отделения
4. Задачи приёмного отделения
5. Устройство приёмного отделения
6. Санитарная обработка и педикулёз
7. Бельевой режим
8. Медицинская документация
9. Правила приёма пациента в стационар · подробнее
10. Педикулёз подробно · подробнее
11. Санитарно-гигиенический режим отделения · подробнее

Суть — главное одной фразой | Простыми словами | Важно | Таблицы

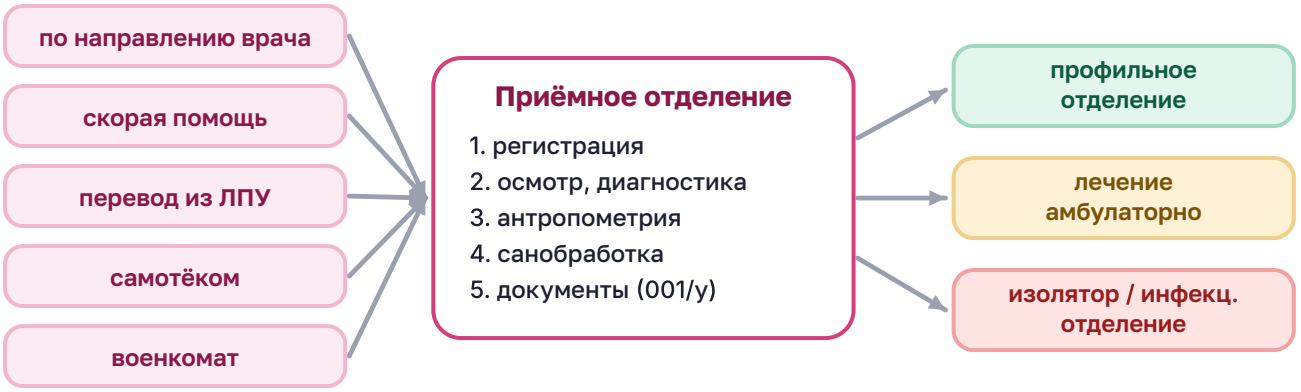
1 Как пациенты попадают в стационар

СУТЬ

В больницу попадают по направлению, на скорой, переводом, по направлению военкомата или «самотёком».

Путь госпитализации	Когда
По направлению участкового врача	лечение в амбулаторных условиях неэффективно
Машиной скорой помощи	несчастные случаи, травмы, острые заболевания и обострения хронических, требующие квалифицированного экстренного лечения в стационаре
Переводом	из других лечебных учреждений (по предварительной договорённости)
Самостоятельно («самотёком»)	пациент сам обратился при ухудшении самочувствия
По направлению военкомата	обследование призывников

Виды госпитализации: плановая, экстренная, самотёком.



Путь пациента через приёмное отделение

2 Приёмное отделение

суть
Приёмное отделение («приёмный покой») — входные ворота стационара, работает круглосуточно.

Приёмное отделение (приёмный покой) — одно из структурных подразделений стационара; является **лечебно-диагностическим**, работает в **круглосуточном** режиме.

Размещение

- **Централизованная** система планировки — все лечебно-диагностические отделения в одном корпусе, приёмное отделение общее.
- **Децентрализованная (павильонная)** — приёмное отделение размещается в отдельном корпусе; в некоторых отделениях (инфекционное, родильное, психиатрический стационар) приём ведут самостоятельно.

3 Функции приёмного отделения

суть
10 функций: от регистрации и осмотра до санобработки, документов и транспортировки.

1. Приём и регистрация пациентов.
2. **Антропометрия** — оценка телосложения: рост, вес, окружность грудной клетки.
3. Врачебный осмотр, первичное обследование и диагностика.
4. Оказание экстренной квалифицированной медпомощи.
5. Определение отделения для госпитализации или лечение в амбулаторных условиях.
6. **Санитарно-гигиеническая обработка** пациента — частичная или полная (вид назначает врач).
7. Оформление медицинской документации (журнал регистрации ф. 001/у).
8. **Транспортировка** пациента — вид определяет врач приёмного отделения: самостоятельно, на каталке, на кресле-каталке, на руках.
9. Консультативная помощь амбулаторным пациентам.
10. Справочные услуги.



Вид транспортировки определяет врач приёмного отделения

Виды транспортировки пациента

4 Задачи приёмного отделения

ВАЖНО
Главная задача — не пропустить инфекционного больного в общий стационар.

1. Выявить пациентов с **инфекционными заболеваниями**.
2. Распределить пациентов по отделениям в соответствии с профилем и тяжестью заболевания.
3. Выявить **непрофильных** пациентов, которые должны лечиться в другом ЛПУ.
4. Оказать экстренную помощь тем, кому она нужна.

5 Устройство приёмного отделения

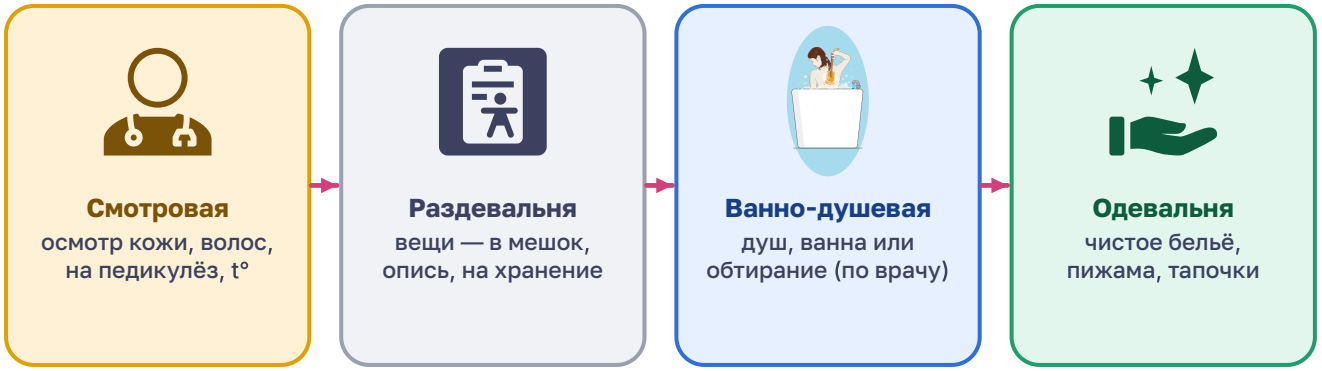
СУТЬ
В приёмном есть всё для первичного осмотра, диагностики, изоляции и санобработки.

1. Регистратура
2. Врачебный кабинет для осмотра
3. Диагностический кабинет
4. Зал ожидания
5. Изолятор
6. Процедурный кабинет
7. Перевязочная
8. УЗИ, КТ, МРТ
9. Санитарный пропускник с душевой для переодевания
10. Санузел
11. Кабинет дежурного врача

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Изолятор нужен как раз для задачи №1: если у пациента подозрение на инфекцию, его сразу отделяют от остальных.

6 Санитарная обработка и педикулёз

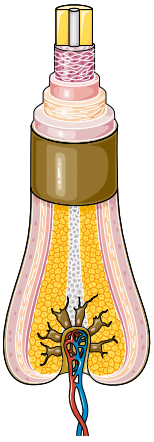
СУТЬ
Каждого поступающего осматривают на педикулёз и при необходимости проводят санобработку в санпропускнике.



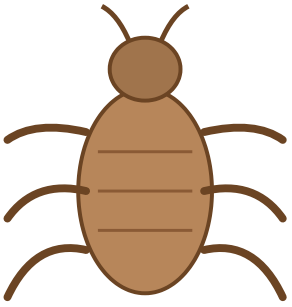
«Грязная» зона → «чистая» зона: после душа пациент не возвращается в смотровую

Санпропускник: движение пациента от грязной зоны к чистой

Санитарно-гигиеническая обработка включает дезинсекцию (при обнаружении насекомых), гигиеническую ванну, душ или обтирание и переодевание в чистое бельё. Проводит медсестра.



волос с гнидами



вошь: 2–4 мм
серо-коричневая, подвижная



гнида (яйцо) приклеена к волосу у корня, не смахивается

где искать: височная и затылочная области, брови, ресницы

Вошь и гниды: как выглядят и где искать

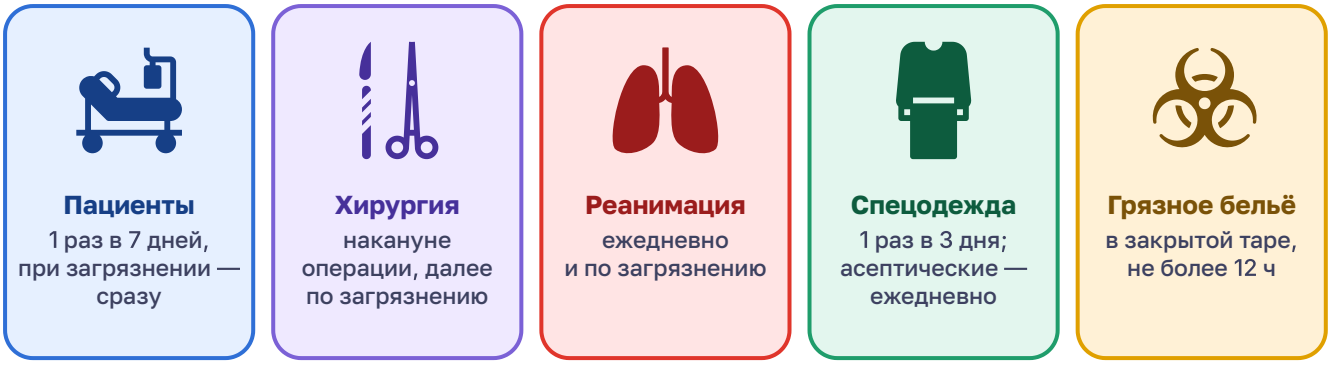
Педикулёз (лат. *pediculum* — вошь) — паразитирование вшей на коже и волосах. Признаки: вши и гниды, зуд, расчёсы, корки. Виды: головная, платяная (переносчик сыпного тифа), лобковая.

1. Регистрация в журнале ф. 060/у.
2. Экстренное извещение ф. 058/у в ЦГиЭ.
3. Отметка на лицевой стороне истории болезни.
4. Санобработка пациента, дезинсекция вещей и помещения.

ВАЖНО
В отделении всех пациентов осматривают на педикулёз **каждые 7 дней**.

7 Бельевой режим

СУТЬ
Бельё меняют по графику и сразу при загрязнении; грязное бельё — только в закрытой таре.



Сроки смены белья и спецодежды

8 Медицинская документация

СУТЬ
Медицинская документация — документы установленной формы; бывает учётной и отчётной.

Медицинская документация — документы установленной формы для регистрации результатов лечебных, диагностических, профилактических, реабилитационных, санитарно-гигиенических и др. мероприятий. Позволяет анализировать и обобщать информацию. Бывает **учётной** и **отчётной**.

Форма	Документ
001/у	Журнал учёта приёма больных и отказов в госпитализации (учётная)
003/у	Медицинская карта стационарного больного
004/у	Температурный лист (давление, рост, вес, температура)
058/у	Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку
060/у	Журнал учёта инфекционных заболеваний
066/у	Статистическая карта выбывшего из стационара
074/у	Журнал регистрации амбулаторных больных
—	Алфавитный журнал поступивших пациентов (в лекции отмечен как 001/у)
—	Журнал телефонограмм

ⓘ **RW** — реакция Вассермана, анализ на возбудителя сифилиса.

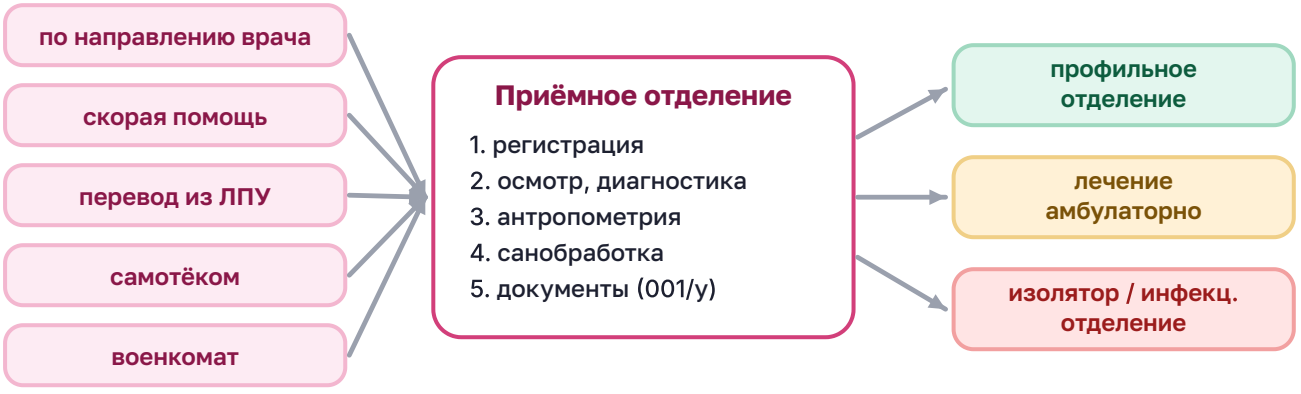
📖 **Подробнее — дополнительные материалы к теме**

9 Правила приёма пациента в стационар

СУТЬ
Цель — не допустить заноса инфекции в стационар и выявить возможный источник инфекции.

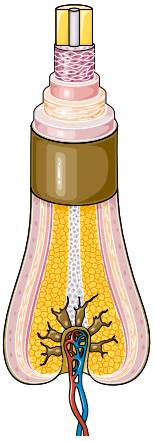
Процесс	Обоснование
Регистрация → врачебный осмотр → санитарная обработка	своевременно выявить больных в инкубационном периоде, со стёртым течением, носителей
Индивидуальный приём, сбор эпиданамнеза (контакты, перенесённые инфекции, поездки)	профилактика заражения персонала и других пациентов
Осмотр на педикулёз, обработка при выявлении	профилактика сыпного тифа и распространения вшей
При подозрении на инфекцию — изоляция, перевод в инфекционное отделение, первичные противоэпидемические меры	изоляция источника

Состав приёмного отделения: зал ожидания, кабинет дежурной медсестры, смотровые, процедурный кабинет, перевязочная, санпропускник, изолятор с отдельным санузлом, рентген-кабинет, лаборатория, санузел.

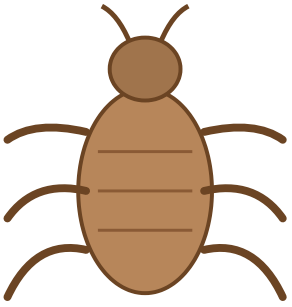


Путь пациента через приёмное отделение

10 Педикулёз подробно



волос с гнидами



вошь: 2–4 мм
серо-коричневая, подвижная



гнида (яйцо)
приклеена к волосу
у корня, не смахивается

где искать:
височная и затылочная
области, брови, ресницы

Вошь и гниды

Вид	Где живёт	Особенности
Головная вошь	волосистая часть головы — височная и затылочная области, брови, ресницы, борода	передаётся при контакте и через расчёски, головные уборы; зуд, расчёсы, колтун
Платяная вошь	складки одежды, переходит на кожу: шея, спина, поясница, подмышки	переносчик сыпного и возвратного тифа, волынской лихорадки; синюшные пятна, нестерпимый зуд
Лобковая вошь	волосы лобка, подмышек, бровей, ресниц	самая маленькая; передаётся половым путём; синюшно-голубые пятна

Противопедикулёзная укладка

Мешок для вещей, клеёнка, косынки, педикулицид, частый гребень, ножницы, лупа, 6% уксус, шампунь, ватные тампоны, перчатки, дополнительный халат, фартук, маска.

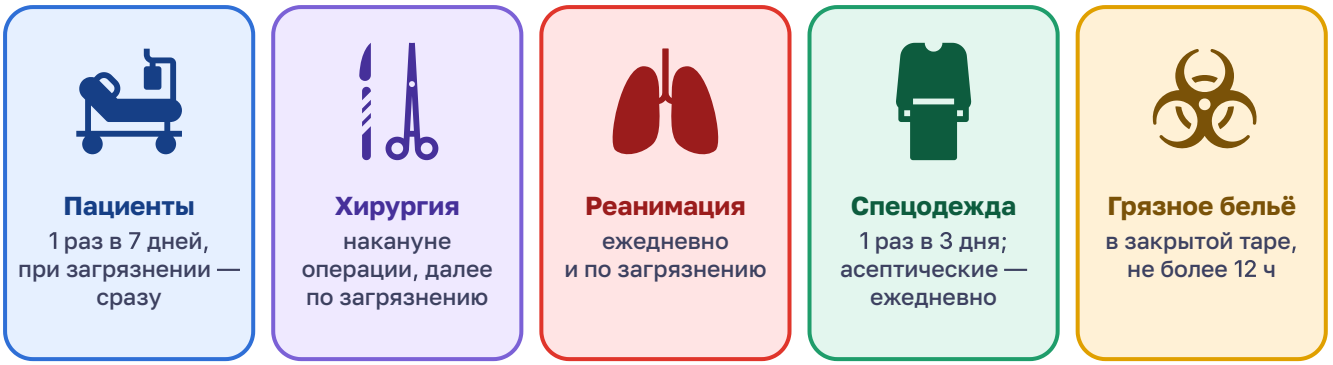
Обработка головы

1. Надеть доп. халат, косынку, маску, перчатки; пациента — на кушетку с клеёнкой, плечи — пелерина.
2. Нанести педикулицид по инструкции, накрыть косынкой, выдержать время.
3. Промыть волосы тёплой водой с шампунем.
4. Ополоснуть тёплым 6% раствором уксуса — для отслоения гнид.
5. Вычесать частым гребнем по прядям, повторно осмотреть.
6. Вещи — в мешок и в дезкамеру; гребень — в дезраствор; помещение обработать.

ВАЖНО
Педикулициды нельзя беременным, кормящим, детям до 5 лет, при болезнях кожи головы и аллергии (Приказ МЗ РФ № 342).

11 Санитарно-гигиенический режим отделения

- поточность заполнения палат; соблюдение правил дезинфекции предметов ухода и обработки посуды;
- строгий бельевой режим; качественные текущие и генеральные уборки; бактерицидные лампы;
- обработка рук, масочный режим, ежедневная смена спецодежды, очерёдность процедур;
- постельные принадлежности после выписки — в дезкамеру.



Бельевой режим

- В акушерстве постельное бельё меняют каждые 3 дня, рубашки и полотенца — ежедневно; у новорождённых — только стерильное бельё.
- Грязное бельё собирают у постели в плотную тару; персонал — в халате, перчатках, маске, косынке.
- Чистое бельё хранят в маркированной таре в чистой бельевой; в отделении — суточный запас.
- Бакконтроль чистого белья — не реже 2 раз в год.

📌 Что запомнить

- Пути госпитализации: по направлению участкового врача, скорой, переводом, самостоятельно, по направлению военкомата.
- Виды госпитализации: плановая, экстренная, самотёком.
- Приёмное отделение — лечебно-диагностическое, работает круглосуточно.
- Вид санобработки (частичная/полная) назначает врач; вид транспортировки определяет врач приёмного отделения.
- Задачи: выявить инфекционных, распределить по профилю и тяжести, выявить непрофильных, оказать экстренную помощь.
- 001/у — журнал приёма и отказов; 003/у — карта стационарного; 004/у — температурный лист; 058/у — экстренное извещение; 060/у — журнал инфекций; 066/у — статкарта выбывшего; 074/у — журнал амбулаторных.
- Педикулёз: журнал ф. 060/у, извещение ф. 058/у, отметка в истории; осмотр в отделении каждые 7 дней.
- Бельё пациентам — не реже 1 раза в 7 дней; спецодежда — раз в 3 дня (асептические — ежедневно); грязное бельё — в закрытой таре до 12 ч.

🃏 Вопросы для самопроверки

Что такое антропометрия?
Оценка телосложения: рост, вес, окружность грудной клетки

Кто назначает вид санобработки?
Врач

Виды транспортировки
Самостоятельно, на каталке, на кресле-каталке, на руках

Форма 001/у
Журнал учёта приёма больных и отказов в госпитализации

Форма 003/у
Медицинская карта стационарного больного

Форма 004/у
Температурный лист

Форма 058/у
Экстренное извещение об инфекционном заболевании, отравлении, необычной реакции на прививку

Форма 066/у
Статистическая карта выбывшего из стационара

Централизованная планировка
Все лечебно-диагностические отделения в одном корпусе

RW
Реакция Вассермана — анализ на сифилис

Как часто осматривают пациентов отделения на педикулёз?
Каждые 7 дней

Где обычно находят головных вшей?
Височная и затылочная области

✅ Тест с ответами

1. В каком режиме работает приёмное отделение?
Ответ: Круглосуточно — Приёмный покой — круглосуточный.

2. Какая форма — медицинская карта стационарного больного?
Ответ: 003/у — 003/у — карта стационарного больного.

3. Экстренное извещение об инфекционном заболевании — это форма…
Ответ: 058/у — 058/у.

4. Кто определяет вид транспортировки пациента?
Ответ: Врач приёмного отделения — Вид транспортировки определяет врач приёмного отделения.

5. Что из этого — задача приёмного отделения?
Ответ: Выявление пациентов с инфекционными заболеваниями — Первая задача — выявить инфекционных больных.

6. Антропометрия включает…
Ответ: рост, вес, окружность грудной клетки — Оценка телосложения.

Конспект составлен по лекции и дополнительным материалам преподавателя. Иллюстрации: схемы — собственные; иконки Healthicons (MIT); рисунки Servier Medical Art (CC BY 3.0), DBCLS (CC BY 4.0) и OpenClipart (CC0) из коллекции Bioicons; слайды — материалы к занятиям.